2023학년도 산부인과 학년말고사 (231030)

* 40분 시험(CBT)

[산과] 30문항

1. 수정란이 자궁내막에 착상한 이후, 황체의 퇴화를 방지하는 역할을 하는 호르몬은? (선지 한글로 출제)
① hCG
② hPL
③ estrogen
④ progesterone
⑤ luteinizing hormone

2. 임신부의 산전 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 카페인은 가급적 하루에 500mg 이하로 섭취하도록 한다.
② 다태임신의 경우 철분을 하루에 300mg 섭취하도록 한다.
③ 비타민 A는 1일 10,000 IU 이상 섭취하였을 경우 선천성 기형의 위험이 증가하므로 주의해야 한다.
④ 일반 산모는 엽산을 매일 0.4mg 복용하도록 권장하고, 신경관 결손 태아를 출산한 기왕력이 있는 산모의 경우에는 엽산을 매일 4mg 복용하도록 권장한다.
⑤ 항응고제 중 큰 분자량을 가지므로 임신 전기간 동안 사용 가능한 것은 와파린이다.

3. 태아 DNA 선별검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 35세 미만 저위험군 임신부에게 가장 적절한 검사는 '태아 DNA 선별검사'가 아니라 '모체혈청 선별검사'이다.
나. 모체 혈액 내 태아 DNA는 임신 4주부터 검출되는 200 base pair 이하의 작은 조각이며 분만 후 2시간 이내에 모체의 혈액으로부터 사라진다.
다. 태아 DNA 선별검사는 임신 10주부터 시행할 수 있다.
라. 21, 18, 13번 상염색체 수적 이상, 성염색체 수적 이상, 그리고 미세 결실의 선별 검사에 활용할 수 있으며, 특히 다운증후군의 경우에는 검출률이 99%로 높다.

① 가나다라
② 가나다
③ 가다
④ 나라
⑤ 라

4. 임신 30주인 25세 미분만부가 1주 전부터 하지 부종과 숨이 찬다며 병원에 왔다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.8℃이다. 골반검사에서 태아는 두위, 자궁목 1cm 확장, 30% 소실, 하강도 -2이다. 가슴 X선 사진은 정상이다. 초음파 상에서 최대 양수수직깊이는 13cm였다. 전자태아심박동-자궁수축감시검사 사진은 다음과 같다. 처치는?
① 경과관찰
② 리토드린
③ 푸로세미드
④ 인도메타신
⑤ 제왕절개술

5. 모체 생리의 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 임신시 느린 호흡 (hypoventilation)에 의한 respiratory acidosis가 발생한다.
② 임신 시 수신증 및 요관수류는 좌측보다 우측에 더 많이 생긴다.
③ 임신시 나타나는 혈뇨나 단백뇨는 무조건 비정상적 소견이다.
④ 임신 시 ALP가 2배 이상 증가한다.
⑤ 임신 시 혈청 내 AST, ALT, 빌리루빈, GGT 농도가 약간 감소한다.

6. 모체 생리의 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① hCG의 역할은 황체 유지이다.
② 제왕자궁절제술 시 혈액의 소실이 1.5L 이상 가능하다.
③ 임신 중 산모의 총 혈액량은 임신 제 32주에 최대치를 보이며 이후 감소한다.
④ 임신 말기 산모의 Hb 농도는 11.0g/dl 이하는 비정상으로 간주한다.
⑤ 임신 제 3분기에 필요한 일일 철요구량은 7mg/dl 이상이다.

7. 환자가 치료받고자 하는 문제에 대해 시간 순으로 명시한 것. 어디가 아프고, onset, duration, 등등 언제 악화되고 언제 완화되는지 등등 알아보는 것과 관련된 사항은?
① Present illness
② Chief complaint
③ Initial assessment
④ Physical examination
⑤ Review of system

8. 36주 산모. NST에서 reactive이고, 30분간 측정 시 태아의 호흡이 10초 지속되는 것을 1회 관찰하였다. 팔다리의 움직임은 30분 동안 2회 관찰되고, 사지의 신전 굴곡은 관찰되지 않았다. Single vertical pocket의 크기가 2.5cm였다. BPP 점수를 구하시오.

① 2점
② 4점
③ 6점
④ 8점
⑤ 10점

9. 26세 임신 37주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP가 8점이었고, single vertical pocket의 크기가 2cm였다. 해야할 조치는?

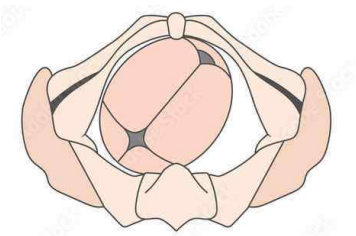
① 1주 뒤 생물리학계수 측정
② 1주 뒤 비수축 검사, 양수량 측정
③ 응급제왕절개
④ 분만
⑤ 경과관찰

10. 후두위의 질식분만 중 Cardinal movement 중에서 fetal occiput이 symphysis pubis를 향하여 앞쪽으로 회전하여 O-A position을 유도하는 과정은?



① Internal rotation
② External rotation
③ Expulsion
④ Descent
⑤ Engagement

11. 다음에 해당하는 Fetal orientation은?



① ROA
② LOA
③ ROP
④ LOP
⑤ OA

12. 다음 약물에 대한 설명 중 옳은 것을 고르시오

가. 임신 중 알콜 과다 섭취는 지금까지 잘 알려진 지능 저하의 가장 흔한 원인으로 특징적인 얼굴 기형과 성장 지연이 동반되는 fetal alcohol syndrome을 일으킬 수 있다.
나. 임신 중 요오드의 방사성 동위원소를 치료목적 으로 사용하는 경우 태아에게 영구적인 갑상선 기 능 저하를 유발할 수 있기 때문에 임신 중 사용 금기이다.
다. NSAID 제제는 일반적으로 선천성 기형과는 큰 연관이 없다고 보고되고 있지만, 임신 초기에 사 용할 경우 유산을 일으킬 수 있고 제3 삼분기에 사용할 경우 태아 동맥관 조기 폐쇄를 일으킬 수 있으므로 임신 제3 삼분기에 사용 금기이다.
라. 이온화 방사선은 수정 후 3주에서 8주 사이에 노출시 주요 기관 기형이 생길 수 있으며, 10~20 mGy 이상 노출 시 IUGR 과 지능 저하를 일으킬 수 있다.

① 가나다라
② 가나다
③ 가다
④ 나라
⑤ 라

13. 임신 36주, 30세 산모가 무통성의 다량의 질출혈로 내원하였다. 이전에도 출혈이 있긴 했지만, 이렇게 심하지는 않았다. 헤모글로빈 수치는 6.9%이었으며, 혈압은 90/60mmHg, 맥박은 110/min이었다. 적절한 처치는?

① 제왕절개
② 경과관찰
③ 옥시토신
④ 양수천자
⑤ 긁어냄술

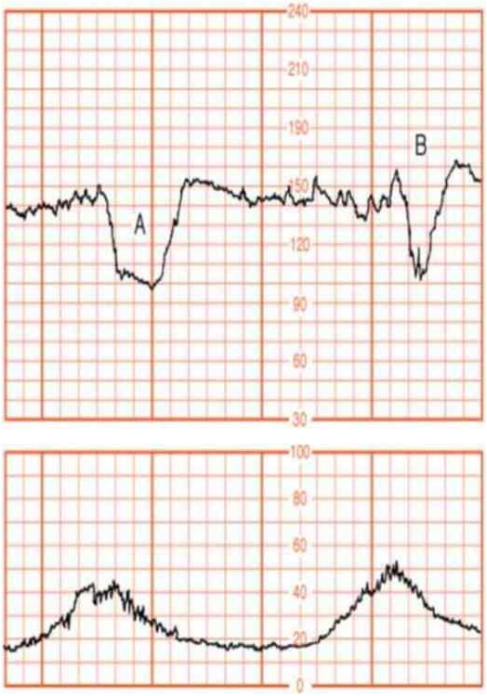
14. 34세 산모가 4.1kg 아이를 성공적으로 질식분만 하고 태반도 완전 만출되었으나 지속적인 질출혈이 있었다. 복부검사에서 배꼽 위가 물렁물렁하게 만져졌다. 다음 중 해야 하는 처치로 옳은 것은?

① 베타메타손
② 리토드린
③ 경과관찰
④ 긁어냄술
⑤ 옥시토신

15. 34세 임신 36 주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 혈압 180/110mmHg, 단백뇨 (4+), 부종(2+, 2+). 자궁경부 1cm 개대, 80% 소실되었고 BPP score 8점이었다. 알맞은 처치는?

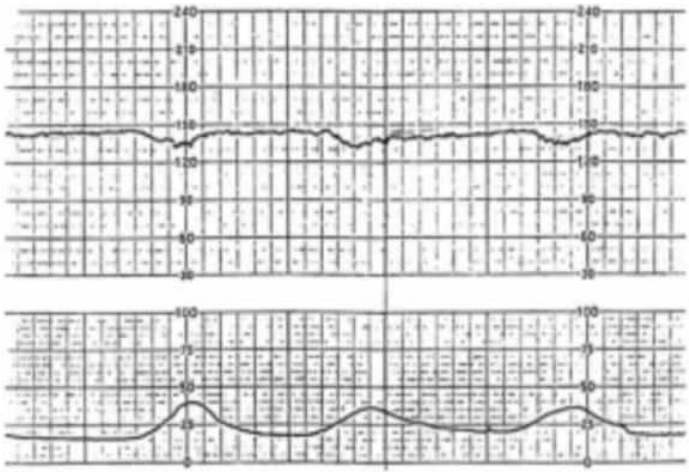
① 분만
② 경과관찰
③ 글루코코르티코이드
④ 황산마그네슘
⑤ 푸로세미드

16. 42주 산모의 태아심박동 검사가 다음과 같이 나왔을 때, 원인으로 가장 알맞은 것은?



① 태반의 노화
② 태아 체중 증가
③ 양수량 감소
④ 태아두위 압박
⑤ 태반기능부전

17. 임신 38주 여성이 진통으로 내원하였다. 자궁경부는 7cm 열려 있었고, 소실도는 80%, 하강도는 +1 이었으며 양막은 파열되지 않았다. 비수축검사 결과가 다음과 같을 때, 가장 적절한 원인은?



① 태아두부압박
② 태아기능부전
③ 제대압박
④ 양수과다
⑤ 태아수면

18. 임신성 고혈압이 있는 임신 36주 산모가 복통을 주소로 내원하였다. 혈압은 180/120이었고, NST는 다음과 같다. 자궁목순화는 일어나지 않았다. 처치는?



(정확히 똑같은 사진은 아니고 prolonged deceleration을 나타내는 NST였습니다.)

① 제왕절개
② 경과관찰
③ 옥시토신
④ 양수주입
⑤ 옆누운자세로 변경

19. 33세 여자. 임신 11주. 산전검사에서 매독혈청검사(VDRL) 결과 양성으로 병원에 왔다. 이 여자는 2년 전 매독으로 치료를 받았다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 처치는?

2년 전: 매독혈청 정량검사 (항체역가 1:8), IgG(+)
현재: 매독혈청 정량검사 (항체역가 1:32), IgG(+)

① 경과관찰
② 벤자틴페니실린G
③ 융모막융모생검
④ 뇌척수액검사
⑤ 치료적 유산

20. 임신 33주, 산과력 0-0-0-0인 산모의 태아 doppler 검사에서 Reversed end diastolic flow가 관찰되었다. 처치는?
① 1주 뒤 생물리학계수 측정
② 1주 뒤 재검사
③ 제왕절개
④ 유도분만
⑤ 경과관찰

21. 앙와위에서 자궁의 윤곽을 파악. 자궁 저부 촉진하고 자궁 옆면을 촉진하고 태아의 팔다리 방향을 확인하는 것으로 태축, 태위, 태향 등을 알 수 있음. 양수과다증이 있거나 산모가 비만일 경우 판단하기 어려움. 이 수기는?
① 맥로버트
② 리트겐
③ 모리쉐
④ 레오폴드
⑤ 피나드

22. 두정위에서 양쪽마루뼈지름(biparietal diameter)이 골반입구를 통과하는 것을 이르는 말은?
① 진입
② 내회전
③ 신전
④ 굴곡
⑤ 하강

23. 임신 40주 다분만부 25세 여성이 규칙적인 진통으로 내원하였다. 자궁경부개대는 1cm, 자궁경부의 숙화 정도는 30%, 태아의 아두하강도는 -1이었다. 16시간이 지난 후에도 자궁경부가 그대로일 때, 진단은?
① Protracted active-phase dilatation
② Arrest of descent
③ Secondary arrest of dilatation
④ Normal labor
⑤ Prolonged latent phase

24. 진통 억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?

칼슘 길항작용
과량시 호흡부전
태아 neuroprotective

① 리토드린
② 황산마그네슘
③ Terbutaline

25. 임신 25주인 34세 미분만부가 산전 진찰을 위해 병원에 왔다. 검사 결과는 다음과 같았다. 혈액 50g OGTT 155mg/dL. 처치는?
① 1주 후 50g OGTT 재검
② Insulin
③ 식이요법
④ 100g OGTT
⑤ 경과관찰

26. 임신 11주인 산모, 질출혈로 내원. 자궁 경부 닫힌 상태. FHR 140. 처치는?
① 절대 안전
② 자궁긁어냄술
③ 저용량 아스피린

27. 10주 산모. USG 사진 보여줌.



① MCDA
② MCMA
③ DCMA
④ DCDA

28. 25주 산모, 쌍둥이 산전진찰 위해 병원 내원. 처치는?

	예측 태아몸무게	최대양수주머니 수직깊이	탯줄동맥도플러초음파	정맥관도플러초음파
여	10백분위수	2cm	정상	정상
남	70백분위수	7cm	정상	정상

① 추적관찰
② 양수감압술
③ 양수주입술
④ 사이막절개술
⑤ 혈관문합 태아경 레이저절제술

29. 임신 22주(24주 이내였음) 산모. 초음파 사진 제시. 처치는?



① 경과관찰
② 자궁목원형결찰술

30. 산과력 2-0-2-2인 36세 여성환자가 6주째 무월경 및 복통을 주소로 내원. 요임신검사 양성. 하복부 심한 통증과 압통 있었음. 더글라스 천자 했더니 50mL의 응고되지 않은 출혈 발견하여 응급수술함. 수술의 이름은?



① 좌측 난관 절제술
② 좌측 난소난관절제술
③ 우측 난관 절제술
④ 우측 난소난관절제술
⑤ 자궁절제술

[부인과] 30문항

31. 터너증후군에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 처음에는 estrogen 0.625-1.25mg/day를 사용하다가, 1-2년 후에 0.3-0.625mg/day로 감량하여 사용한다.
② growth hormone으로 먼저 키를 성장시키며, 2-8세에 치료를 시작하여 4-16cm 성장을 목표로 한다.
③ 자궁이 있으므로 프로게스테론을 사용한다.
④ 드물지만 Y chromosome이 있는 경우에는 gonadoblastoma의 발생을 예방하기 위하여 streak gonad를 제거한다.
⑤ 유방발육을 위하여 estrogen을 투여하며, 12-13세에 시작한다.

32. 47세 산과력 2-0-0-2인 여자가 외음부 가려움증과 질분비물 증가로 내원하였다. 수년 전부터 전신홍반루푸스, 당뇨로 내과에 다니며 약을 복용중이라고 한다. 질경 삽입 후 관찰한 소견은 아래와 같았고, 지궁 경부 운동 압통이 나타났다. 적절한 치료는?



① 암피실린
② 이트라코나졸
③ 메트로니다졸
④ 클린다마이신
⑤ 아지트로마이신

33. 35세, 산과력 0-3-0-0인 여성이 무월경으로 내원하여 소변 hCG 양성이었다. 체온 36.3도, 혈압 110/90, 심박수 78, 호흡수 20회였다. CBC도 정상수치였다. 1년 전 자궁내장치 시술을 받았다고 했으나, 질경 검사에서 자궁내장치의 실이 보이지 않았다. 초음파 소견은 아래와 같다. 적절한 조치는?



① 초음파 검사 하에서 자궁내장치 제거
② 입원 후 융모막 융모 검사
③ 프로게스테론 투여
④ 경과 관찰
⑤ 항생제 투여

34. 산과력이 0 0 0 0 인 24세 여성, 신장이 156cm이고 체중 91kg이다. 환자는 다모증 소견이 있고, 월경 주기는 60일로 불규칙하였다. 다음은 환자의 초음파 내시경 사진이다. 이 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① AMH가 주로 증가하고, LH도 증가한다.
② Microcyst가 12개 나타난다.
③ LH/FSH가 증가하고 SHBG도 증가한다.
④ 치료는 체중 감량이 제일 좋은 방법이다. 인슐린 민감성을 높이기 위해 Metformin을 사용할 수도 있다.
⑤ 난소에서 안드로겐 생성이 증가한다.

35. 생리주기가 60일로 불규칙한 35세 여성이 질출혈로 내원하였다. 출혈은 소량이고, 혈압은 110/90mmHg, 헤모글로빈은 10.3 mg/dL로 측정되었다. 이 환자의 치료에 대한 설명을 옳지 않은 것은?
① 희발월경이므로 TSH, Prolactin 혈중치 측정해야 한다.
② 35세 이상이거나 길항되지 않는 에스트로겐 노출 병력이 있으면 자궁내막조직검사와 경질 초음파를 시행해야한다.
③ 자궁내막염, 항정신성 약물, 다낭성 난소증후군 등을 감별해야 한다.
④ 경구피임약 금기이면 프로베라 10mg을 최소 3개월 간 14일 투여, 14일 휴약주기를 주어야 한다.
⑤ 경구 피임약을 하루에 3회, 3일 투여 후 tapering 해야 한다.

36. 48세 여성, 산과력 2-0-0-2. 배가 나와서 만져진다. 빈뇨 증상으로 비뇨의학과 방문하여 방광염이 있어서 항생제 치료를 받고 있다. 평소에 월경통이나 월경과다는 없었다고 한다.
CBC 수치(Hb 정상 이었음)
(크기가 190mm인 자궁근종이 MRI 상에 복강 전체에 꽉 차 있었음) 치료는?
① 전자궁절제술
② HIFU
③ 경과관찰
④ GnRH agonist
⑤ progesterone

37. ??세 여성이 자궁경부암 검사 소견 이상으로 내원. 가장 적절한 치료는?

Cytology	HPV	Punch biopsy		Endometrial biopsy
ASC-H	58	Chronic cervicitis	No malignancy	No malignancy

① 경과관찰
② 6개월 후 pap smear, HPV, biopsy 시행
③ 환상전기소작술

38. 56세 여성이 난소암의 종양감축술을 받고 병리검사 결과가 다음과 같다. 난소암의 병기는?

Ovary and salpinx, bilateral, salpingoophorectomy:
Serous adenocarcinoma, moderately differentiated,
with 1) tumor size: 2.5 x 2.3 x 2cm (right ovary, 1.7 x 1.7 x 1.5cm
(left ovary)
2) involvement of bilateral ovarian capsules with penetration
Washing cytology: malignant cell (+)
Pelvic and para-aortic lymphadenectomy
Pelvic LN metastasis (1/21) size: 7mm
Para-aortic LN metastasis (-)
Omentum, omentectomy: 1.5cm sized metastatic tumor (+)

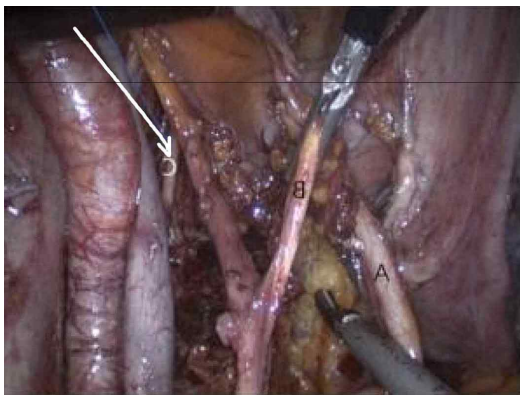
① IC1
② IIIA1(i)
③ IIIC1(ii)
④ IIIA2
⑤ IIIB

39. 56세 여성이 상피성 난소암이 의심되어 병기결정술을 받았다. 수술 중 시행한 frozen biopsy에서 clear cell adenocarcinoma였다. 이 여성이 시행 받지 않았을 가능성이 가장 높은 것은?
① 전자궁절제술
② 양측 자궁부속기 절제술
③ 그물막 절제술
④ 충수돌기 절제술
⑤ 대동맥주위 림프절 절제술

40. 과배란유도와 IVF-ET에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 임신확인은 배아이식 11일 후에 hCG를 통해 체크한다.
② 생리 9~10일째 follicle이 25개 이상이거나 E2>4000일 때, 또는 LH가 30mIU/ml이상일때, 과배란 유도를 취소한다.
③ 황체보강을 위한 progesterone 투여는 배아 이식 당일부터 시작한다.
④ 다태임신 방지를 위해 최근 이식되는 배아의 수는 2~4개로 제한한다.
⑤ 배아이식은 난자 채취후 2~3일후 4~8cell embryos를 질식카테터를 넣어서 질식 초음파를 통해 시행한다.

41. 다음중 과배란 유도후 생길수 있는 OHSS의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① OHSS를 예방하는 방법으로 gonadotropin 투여를 중지하고, 1-3일까지 hCG를 늦추는 coasting 방법을 사용하면 도움이 된다.
② OHSS를 예방하는 방법으로 최종 난자 성숙을 위해 낮은 용량의 hCG나, recombinant LH 또는 GnRH antagonist를 투여하는 것도 도움이 된다.
③ 난자 채취 후 7일 이내에 생기는 경우 초기 OHSS로 정의하며 혈중 estradiol이 높은 경우와 난자 개수가 관련이 있다.
④ 중증 OHSS는 약 1%에서 나타나며, 호흡곤란, 복부팽만 등 생명을 위협할 수도 있다.
⑤ 체외수정시술을 위한 과배란 유도로 난소 과자극 증후군이 생긴 경우 해당 주기를 취소하고 모든 배아를 냉동보관하는 방법도 있다.

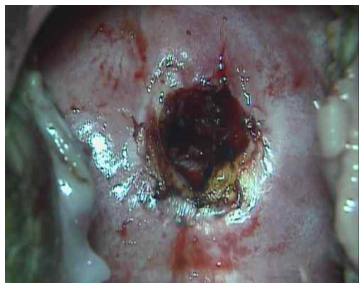
42. 자궁경부암 환자의 수술 사진이다. 화살표로 표시한 구조물은?



① left ureter
② left obturator nerve
③ left uterine artery
④ left external iliac vein
⑤ left external iliac artery

43. 산과력 3-0-4-3인 55세 여성이 성교 후 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL이었다. 자궁 경부에 2~3cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?
① 단순 전자궁적출술
② 이미 conization을 실시하였으므로 경과를 관찰한다.
③ 다시 conizaiton을 실시한다.
④ 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술

44. 산과력이 2-0-3-2인 45세 여자가 질 출혈을 주소로 내원하였다. 이전에 HSIL로 판명되어 conization을 시행했다. Colposcopy 결과 깊이 2mm, 넓이 6mm인 자궁겨부 침윤성 편평세포암종이 발견되었다. 환자가 더 이상 임신할 계획이 없다고 할 때, 적절한 치료는?



① 전자궁적출술
② 정기적 추적관찰
③ 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
④ 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 전골반내용적출술

45. 산과력 2-0-1-2인 60세 여성이 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결가 HSIL 이었다. 자궁경부에 3~4cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 진찰 및 MRI 소견이다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?

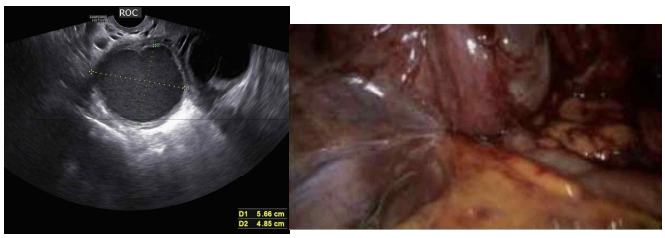


① 단순 전자궁적출술
② 동시항암화학방사선치료
③ 정기적 추적관찰
④ 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 변형된 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술

46. 산과력이 2-0-1-2인 60세 여성이 자궁경부암으로 치료를 받았다. 근치적 자궁절제술 및 배막뒤림프절절제술을 시행했는데, 수술 소견은 다음과 같다. 골반강 근처 림프절은 전이되었지만 대동맥 근처 림프절은 전이되지 않았다. 환자의 병기와 다음으로 해야 할 처치는?

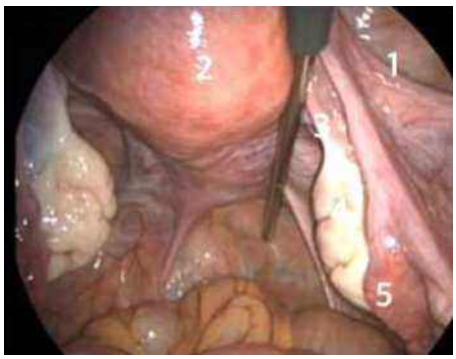
① ⅡC, 면역요법
② ⅢC1, 항암화학요법
③ ⅢC2, 항암화학요법
④ ⅢC1, 동시항암화학방사선치료
⑤ ⅢC2, 동시항암화학방사선치료

47. 초음파 소견상 간유리 같은 음영이 보였다. 초음파 소견과 복강경 소견은 다음과 같다. 진단은?



① 자궁내막증과 곧창자와 난소 유착
② 자궁근종
③ 자궁내막암

48. 다음 복강경 자궁 수술 시야 사진에서 보이는 구조물을 순서대로 쓰시오.



① Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right ovary-Right infundibulopelvic ligament
② Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
③ Round ligament-Uterus-Left ovarian ligament -Left ovary-Left infundibulopelvic ligament
④ Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament -Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
⑤ Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament -Right ovary-Right infundibulopelvic ligament

49. 산과력 0-0-1-0인 30세 여자가 질 출혈을 주소로 내원하였다. 자궁흡입긁어냄술 결과 완전포상기태를 확인하였고, hCG 검사가 아래 표와 같았다. 흉부 X선 검사 및 CT 단층촬영 소견이 정상이었다. 이 환자에게 해야 할 처치는?

자궁흡입긁어냄술	
시행 전	120,000mIU/mL
1주 후	80,000mIU/mL
2주 후	45,000mIU/mL
3주 후	20,000mIU/mL
6주 후	9,800mIU/mL
9주 후	860mIU/mL
12주 후	92mIU/mL

① 복합경구피임제
② 자궁절제술
③ 프로게스테론
④ 자궁흡입긁어냄술
⑤ GnRH agonist

50. 55세 산과력 3-0-1-3인 여성이 6개월 전부터 웃거나 재채기할 때 소변이 새서 병원에 왔다. 골반 검사에서 방광탈출이나 자궁탈출증은 없었고, 골반 초음파검사에서도 자궁과 자궁부속기는 정상이었다. 요역동학 검사에서 배뇨근의 수축 없이 방광내압이 요도폐쇄압을 넘을 때 소변이 샜다. Q-tip test 시 40도만큼 올라갔다. 적절한 치료는?

① 케겔 운동
② 질식자궁절제술
③ 항콜린제
④ 무긴장성 테이프
⑤ 전방질복합술

51. 산부인과 환자가 로봇 수술을 시행 후 3일 후에 복부팽만과 아랫배 통증을 호소하여 다시 내원하였다. 환자에게 실시한 Simple X-ray 결과는 다음과 같았다. 환자에게 해야 할 처치는?



① 수액치료
② 관장
③ 경피적 배액흡인술
④ 직장 관 삽입?
⑤ 항생제

52. 다음 중 distension media에 대한 설명으로 옳은 것은?
① Normal saline은 가장 안전한 경부 확장제이다.
② Dextran 70을 사용하면 출혈 때문에 시야가 좋지 않다.
③ Hysteroscopy를 시행할 때 질 경부 확장제를 통한 전처치가 필요없다.
④ CO2는 자궁 polyp을 제거할 때 가장 적절하게 사용할 수 있는 자궁확장제이다.
⑤ 자궁천공이 일어나도 안전하므로 계속 수술을 시행한다.

53. 50세 산과력 2-0-1-2인 여성이 질출혈로 내원했다. 부인과 초음파 결과 자궁내막의 두께가 25mm로 측정되어 자궁내막조직검사를 시행하였고, 그 결과 자궁내막양 자궁내막암으로 진단되었다. 환자는 신장 165cm, 체중 115kg이다. 폐경은 45세였고, 당뇨 있으며, 2년전부터 다낭성난소증후군으로 진단되었지만 별다른 치료는 하지 않았다. 6개월 전 내원해서 자궁내막 양성 증식증을 진단 받은 적이 있으나 치료는 받지 않았다. 환자의 과거력 중 가장 큰 위험요인으로 작용한 것은?
① 당뇨
② 비만
③ 자궁내막 양성 증식증
④ 다낭성난소증후군
⑤ 폐경 시기

54. 사춘기 조발증(성조숙증, precocious puberty)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 8세 이전에 이차 성징이 나타나는 것으로 여아에서 남아보다 흔하며 유방발달, 음모 출현, 질 출혈 등이 나타난다.
② 최종 키 손실의 최소화가 중요하므로 키의 정상적인 성장을 유도하고 이차 성징의 발현을 억제하는 것이 중요하다.
③ 치료 시 혈중 E2<10 pg/ml로 유지하면서 Epiphysis가 fusion되거나 bone/chronologic age가 일치할 때까지 치료를 한다.
④ 사춘기 조발증의 1차적 치료제는 GnRH agonist로 bone age가 13-15세일 때 사용하면 효과적이다.
⑤ 기질적인 뇌 병변을 감별해야 하므로 Brain MRI 등 진단 영상학적 검사를 일차 검사로 해야 한다.

55. 16세 여자가 초경이 없어서 병원에 왔다. 초음파 검사에서 자궁이 작게 관찰되었다. 혈중 prolactin, TSH level은 모두 정상 범위였고, 이학적 검사 소견도 정상이었다. Progesterone challenge test에서는 출혈이 전혀 없었다. FSH level이 93mIU/mL 이었을 때, 이 환자의 상태로 가장 가능성이 낮은 진단은 무엇인가?
① Turner syndrome
② Premature ovarian failure
③ Androgen insensitivity syndrome
④ Kallmann syndrome
⑤ Swyer sndrome

56. 만성골반통의 치료로 옳지 않은 것을 고르시오.
① 주로 20세-40세 사이의 생식적으로 완성된 기혼 경산부 여성에서 잘 나타난다.
② 자궁내막증은 이차성 월경통 및 만성 골반통의 가장 흔한 원인으로 자궁내막증 병변 주위의 염증성 변화에 의한 통증과 자궁내막증 병변 자체의 통증이 해당된다.
③ 자궁샘근증은 이차성 월경통 및 만성 골반통의 두 번째로 흔한 원인으로 자궁자체의 크기가 커짐에 따라 자궁내막의 양이 늘어나 과다 월경과 심한 월경통을 일으킨다.
④ 골반울혈증은 만성 골반통의 세번째로 흔한 원인이고 MPA 30mg/day를 사용하였을 때 효과가 없으므로 경피적 색전술 또는 선택적 혈관 색전술을 시행하야 한다.
⑤ 자궁샘근증에서 자궁을 보전하여야 하는 경우 NSAIDs를 생리 때마다 투여하고 이에 반응하지 않는 경우 최근 Levonorgesterol(LNG)를 함유한 Mirena가 효과적이다

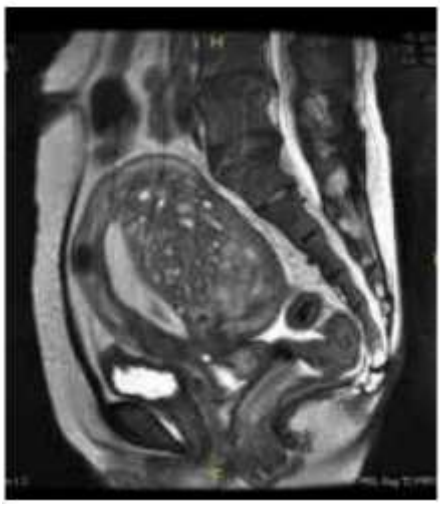
57. 폐경 후 호르몬 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 호르몬 요법이 고혈압에 미치는 영향은 매우 미미하다.
② 루푸스 환자가 폐경 증상을 호소할 때, 비활동성 상태이면서 항인지질 항체 음성을 보이고, 신장질환이 동반되지 않았다면 최소용량으로 최소기간 동안 호르몬 요법을 시행할 수 있다.
③ 혈전 색전증의 기왕력이 있다면 경구 호르몬 요법은 금기이지만 경피 투요 또는 낮은 용량의 에스트로겐은 사용할 수 있다.
④ 폐경 호르몬 요법이 제 2형 당뇨병에 나쁜 영향이 있어, 경피 투여로 시행할 수 있다.
⑤ 심한 간 질환의 경우, 호르몬 요법이 금기이다.

58. 20세 대학생이 3시간 전부터 시작된 극심한 좌하복부 통증으로 응급실 방문하였다. 활력징후 110/70-75-24-36.9였고, 마지막 생리일은 2주 전이었고, 성경험은 있었다. 응급실에서 시행한 CT 소견이 다음과 같다면, 올바른 진단은?



① 난소 기형종
② Endometrial sinus
③ Endometrial hyperplasia

59. 다음 MRI 소견의 PALM-COEIN stage 소견은?



① AUB-A
② AUB-L
③ AUB-M
④ AUB-P
⑤ DUB

60. 다음중 다태임신의 초기진단에 유용한것은?
① 자궁경
② 초음파
③ 월경력 및 문진
④ MS AFP
⑤ hCG